

UNOESTE - HRPP | 2026

R1 ACESSO DIRETO

1 - Clínica Médica - Homem de 65 anos relata episódios de palpitação, de curta duração, há uma semana. AP: insuficiência cardíaca de fração com fração de ejeção de 46%, em uso de enalapril e espironolactona. Ao exame físico, encontra-se normal, exceto por frequência cardíaca de 120 bpm. Ao eletrocardiograma, o paciente apresenta ritmo de fibrilação atrial. Foi optado por realizar estratégia de controle de ritmo. De acordo com as diretrizes europeias (ESC) de 2024, o tratamento farmacológico de primeira linha a ser utilizado deve ser:

- A) Propafenona.
- B) Sotalol.
- C) Diltiazem.
- D) Amiodarona.
- E) Metoprolol.

2 - Mulher de 76 anos relata queixa de tontura após levantar-se da cama pela manhã, com sensação descrita como "cabeça vazia", que dura alguns segundos e que melhora após ela se sentar ou deitar novamente. AP: depressão (em tratamento com amitriptilina) e menopausa (em manejo com terapia de reposição hormonal). Relata ainda uso ocasional de anti-inflamatórios não esteroidais em casos de dores articulares, suplementos herbais à base de ginseng e descongestionantes nasais com pseudoefedrina. Ao exame físico, apresenta pressão arterial de 128x75 mmHg deitada e de 112x61 mmHg após três minutos em pé. Os achados clínicos encontrados nessa paciente podem ser explicados pelo uso de:

- A) Amitriptilina.
- B) Terapia de reposição hormonal baseada em estrogênio.
- C) Suplementos herbais com ginseng.
- D) Anti-inflamatórios não esteroidais.
- E) Pseudoefedrina tópica nasal.

3 - Mulher de 82 anos relata dor torácica de forte intensidade iniciada há duas horas. AP: hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e AVC isquêmico há dois anos. Exame físico normal. Em eletrocardiograma, apresenta supradesnívelamento do segmento ST em derivações precordiais de V1 a V6. A paciente será encaminhada à sala de hemodinâmica para realização de angioplastia primária. De acordo com a atualização de 2025 da diretriz American Heart Association, além do AAS, o que mais deve ser adicionado ao tratamento farmacológico?

- A) Apenas prasugrel.
- B) Apenas ticagrelor.

- C) Prasugrel e enoxaparina.
- D) Prasugrel e heparina não fracionada.
- E) Ticagrelor e heparina não fracionada.

4 - Homem de 38 anos relata presença de dor, eritema, edema e limitação da mobilidade em joelho esquerdo há um dia. Relata que o episódio iniciou espontaneamente e evoluiu de modo progressivo. Nega ocorrências prévias. Nega demais queixas. AP: obesidade, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e início recente de tratamento para tuberculose. Ao exame físico, apresenta joelho esquerdo com edema, eritema e calor local. Foi realizada artrocentese com análise de líquido sinovial apresentando 10.000 leucócitos/mm³ e presença de cristais. Qual medicação pode estar relacionada ao quadro atual do paciente?

- A) Isoniazida.
- B) Pirazinamida.
- C) Losartana.
- D) Anlodipino.
- E) Atorvastatina.

5 - Mulher de 32 anos relata mialgia e fraqueza muscular há seis meses. Relata que os sintomas iniciaram com dificuldades de subir escadas e progrediram para dificuldade em se levantar de cadeiras. Há duas semanas, tem apresentado dispneia aos pequenos esforços. Nega antecedentes patológicos prévios e uso de medicações. Em exame físico, apresenta SpO₂ de 90% em ar ambiente, fraqueza muscular proximal em membros superiores e inferiores e mãos de mecânico. Em exames laboratoriais, apresenta elevação de CPK e anti-Jo1 positivo. Uma tomografia de tórax deve ser realizada nessa paciente devido a risco de:

- A) Derrame pleural.
- B) Tromboembolia pulmonar.
- C) Doença intersticial pulmonar.
- D) Neoplasia de pulmão.
- E) Cavitações pulmonares e bronquiectasias.

6 - Homem de 22 anos apresenta crises de tosse seca e sibilância de uma a duas vezes por mês, principalmente durante o dia, após exposição a poeira, com duração de algumas horas depois de se afastar da exposição. Nega antecedentes patológicos, uso de medicamentos, internações prévias e alergias. Exame físico normal. Realiza espirometria com resultado normal e apresenta teste de broncoprovocação positivo. De acordo com as diretrizes da *Global Initiative for Asthma* de 2025, é correto afirmar que o tratamento farmacológico:

- A) Não deve ser iniciado, pois não há conclusão diagnóstica para o paciente.
- B) Não deve ser iniciado, pois, pelo padrão intermitente dos sintomas, deve-se inicialmente tentar a redução da exposição.
- C) Deve ser iniciado preferencialmente com corticoide e formoterol inalatórios em caso de sintomas.
- D) Deve ser iniciado preferencialmente com β2-agonista de curta duração em caso de sintomas.

E) Deve ser iniciado preferencialmente com corticoide inalatório diário em baixas doses associado a β 2-agonista de curta duração em caso de sintomas.

7 - Mulher de 38 anos relata dispneia aos esforços, com evolução progressiva há dois anos. Não relata antecedentes patológicos ou uso de medicamentos. Exame físico normal. Foi realizado ecocardiograma para investigação, que mostrou PSAP de 58 mmHg, fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 68%, sem alterações detectadas em átrio e ventrículo esquerdo, sem alterações em pericárdio nem em válvulas mitral e aórtica. Com base nesse caso, assinale a alternativa correta.

A) As causas mais comuns relacionadas a essa situação são doença tromboembólica e doenças pulmonares crônicas.

B) A próxima medida para investigação diagnóstica é a determinação do volume sistólico do ventrículo esquerdo.

C) Epidemiologicamente, é maior a probabilidade de que as etiologias do grupo 5 estejam envolvidas nesse caso.

D) A ausência de alterações ecocardiográficas em coração esquerdo indica provável causa idiopática das alterações encontradas.

E) As principais etiologias infecciosas envolvidas nesse caso são HIV, hepatite B e hepatite C.

8 - Em relação ao uso de corticosteroides para o tratamento de pneumonia adquirida na comunidade, é correto afirmar:

A) Deve ser utilizado em pneumonias com etiologia viral, como aquelas causadas por covid-19 e influenza.

B) Evidências atuais apontam benefício do uso, com melhora em mortalidade, para quadros graves (PSI IV ou V).

C) São indicados em situações de necessidade de hospitalização, como necessidade de uso de oxigênio ou pacientes em extremos de idade.

D) As evidências são consensuais para aumento de mortalidade, tempo de internação hospitalar e de ventilação mecânica com seu uso.

E) Os estudos que demonstraram benefícios validaram o uso de metilprednisolona e prednisona como principais opções de drogas.

9 - Homem de 55 anos relata melena há três dias, associado a dois episódios de hematêmese há uma hora. Em avaliação endoscópica de urgência, o paciente foi diagnosticado com doença ulcerosa péptica. Diante desse quadro clínico, qual é o método diagnóstico de maior acurácia para infecção por *Helicobacter pylori*, recomendado pelo IV Consenso Brasileiro sobre Infecção por *Helicobacter pylori*?

A) Teste rápido da urease.

B) Teste histológico.

C) Sorologias.

D) Testes moleculares.

E) Teste respiratório com ureia ^{13}C .

10 - Homem de 69 anos apresenta alteração do estado mental, associada a sonolência e confusão, há quatro dias. AP: cirrose hepática em tratamento com furosemida e espironolactona. Exame físico: ascite de moderada intensidade, além de *flapping* positivo, sem outros achados. Além da paracentese, as medidas que devem ser tomadas são:

- A) Aumento da dose dos diuréticos e introdução de metronidazol, apenas.
- B) Aumento da dose dos diuréticos e introdução de lactulose e metronidazol, apenas.
- C) Suspensão do uso dos diuréticos e introdução de lactulose, apenas.
- D) Suspensão do uso dos diuréticos e introdução de metronidazol, apenas.
- E) Suspensão do uso de diuréticos e introdução de lactulose, metronidazol e L-ornitina-L aspartato.

11 - Homem de 42 anos relata dor abdominal de forte intensidade e diarreia sanguinolenta há dois dias. Relata que tem evoluído com distensão abdominal e febre alta. AP: retocolite ulcerativa sem tratamento atual. Ao exame físico, o paciente apresenta febre, desidratação e taquicardia. Em exames laboratoriais, o paciente apresenta elevação de PCR e leucocitose. A radiografia de abdome mostra dilatação de cólon, com diâmetro de 8 cm. O tratamento inicial deve ser realizado com:

- A) Metotrexato.
- B) Azatioprina.
- C) Micofenolato.
- D) Ciclofosfamida.
- E) Corticosteroides.

12 - Mulher de 44 anos relata perda de peso associada a hipersensibilidade há três meses. Esse sintoma é acompanhado de aumento da irritabilidade, insônia, sudorese excessiva, episódios de diarreia e intolerância ao calor. Nega antecedentes patológicos e uso de medicamentos. Ao exame físico, apresenta-se com pele úmida e eritematosa, proptose ocular, bócio, hipertensão, taquicardia e tremores de extremidades. Em relação ao caso, as opções terapêuticas que agem de modo periférico, reduzindo a conversão no hormônio efetor, são:

- A) Colestiramina e corticosteroides.
- B) Colestiramina e propranolol.
- C) Carbonato de lítio e metoprolol.
- D) Corticosteroides e propranolol.
- E) Corticosteroides e carbonato de lítio.

13 - Homem de 52 anos relata perda de peso associada a náuseas e dor abdominal generalizada há um ano. Além disso, apresenta episódios de redução do nível de consciência, identificados como hipoglicemia. AP: hipertensão arterial sistêmica com atual suspensão dos anti-hipertensivos. Ao exame físico, o paciente encontra-se com hipotensão ortostática e dor abdominal à palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal. Em exames laboratoriais, apresenta cortisol sérico de 1,8 µg/dL às 8h da manhã. A sequência da investigação etiológica deve ser realizada com a solicitação de:

- A) Cortisol matinal após teste da cortrosina.

- B) Cortisol urinário de 24 horas.
- C) Cortisol salivar à meia-noite.
- D) Dosagem de ACTH sérico.
- E) Tomografia computadorizada de adrenais com contraste.

14 - Homem de 50 anos está em avaliação de rotina. Apresenta histórico patológico de diabetes mellitus do tipo 2 e obesidade. Exame físico normal. Em ultrassonografia abdominal, foi detectada esteatose hepática de grau moderado. Após exames laboratoriais, apresenta: AST: 30 U/L; ALT: 25 U/L; plaquetas: 250 x 10⁹/L. Foi calculado escore FIB-4 com valor de 1,20. Em relação ao seguimento das alterações hepáticas, além da proposta de mudança de estilo de vida, a conduta deve ser:

- A) Reavaliação em dois anos.
- B) Reavaliação em um ano.
- C) Reavaliação em seis meses.
- D) Introdução de pioglitazona.
- E) Introdução de liraglutida.

15 - Em relação ao tratamento da dislipidemia em pacientes portadores de diabetes mellitus, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, assinale a alternativa correta.

- A) Em pacientes com risco cardiovascular muito alto, o alvo terapêutico para o LDL-c deve ser abaixo de 70 mg/dL.
- B) Para tratamento de hipertrigliceridemia, é recomendado o uso associado de estatinas e niacina.
- C) O tratamento de hipertrigliceridemia com valores de triglicérides entre 400 e 880 mg/dL deve ser iniciado com fibratos.
- D) Em pacientes com risco cardiovascular intermediário, a introdução de estatina é recomendada independentemente dos valores de LDL-c.
- E) Os inibidores da PCSK-9 possuem média de redução do LDL-c semelhante a estatinas de alta potência, não sendo, por isso, recomendada a sua associação.

16 - Mulher de 40 anos relata queixas de dispneia, astenia e adinamia há seis meses. Nega antecedentes patológicos e uso de medicamentos. Ao exame físico, encontra-se com palidez cutânea, glossite atrófica e hematomas em membros. Em exames laboratoriais, apresenta: hemoglobina: 6,2 g/dL; VCM: 125 fl; leucócitos totais: 2.500/mm³, com neutrófilos hipersegmentados, e contagem de plaquetas igual a 32.000/mm³. Em relação à investigação etiológica, deve-se solicitar dosagem de:

- A) Anticorpos anticélulas parietais.
- B) Anticorpos antitransglutaminase.
- C) Fator antinuclear.
- D) Anticorpos antimúsculo liso.
- E) Anticorpos antiendomísio.

17 - Homem de 19 anos relata queixa de edema em lábios e eritema em região de tronco, além

de dispneia, sibilância e lipotimia, iniciados há vinte minutos, após ter sofrido acidente com picada de abelha. Nega antecedentes patológicos e uso de medicamentos. Ao exame físico, o paciente apresenta-se com angioedema em lábios, eritema morbiliforme em tronco, taquipneico, taquicárdico, com pressão arterial de 82x45 mmHg e ausculta respiratória com murmúrio vesicular reduzido bilateralmente e presença de sibilos expiratórios difusos.

- A) A etiologia do quadro apresentado pelo paciente é responsável pela maior parte dessa síndrome no mundo.
- B) Para estabelecer o diagnóstico definitivo, é necessária a dosagem de triptase e histaminas séricas.
- C) Os sintomas cutâneos são os mais frequentes na apresentação desse quadro clínico.
- D) o tratamento deve ser realizado inicialmente com ressuscitação volêmica e noradrenalina intramuscular.
- E) os corticoides têm ação no controle do broncoespasmo, com início de ação em uma a duas horas.

18 - Mulher de 68 anos apresenta sintomas de palpitação e síncope. Em avaliação eletrocardiográfica, encontra-se taquicardia ventricular, sendo prontamente cardiovertida. AP: leucemia mieloide aguda em tratamento citotóxico, com última infusão há três dias. O exame físico mostra edema em membros inferiores. Exames laboratoriais: ácido úrico: 11,5 mg/dL; potássio sérico: 7,2 mEq/L; fósforo sérico: 8,1 mg/dL; cálcio sérico: 8,5 mg/dL. O tratamento dessa paciente deve ser com:

- A) Alopurinol, gluconato de cálcio em infusão contínua por seis horas, solução de insulina com glicose e diurético de alça.
- B) Alopurinol, gluconato de cálcio 1 g em cinco minutos, solução de insulina com glicose e diurético de alça.
- C) Alopurinol, gluconato de cálcio 1 g em cinco minutos e poliestirenosulfonato de cálcio.
- D) Rasburicase, gluconato de cálcio em infusão contínua por seis horas, solução de insulina com glicose e diurético de alça.
- E) Rasburicase, gluconato de cálcio 1 g em cinco minutos, solução de insulina com glicose e diurético de alça.

19 - Mulher de 73 anos apresenta-se ao pronto-socorro para avaliação, sendo coletada gasometria arterial com o seguinte resultado: pH: 7,18; bicarbonato: 14 mEq/L; pCO₂: 28 mmHg; sódio: 130 mEq/L; cloro: 110 mEq/L. Foram coletadas medidas de sódio urinário (90 mEq/L), potássio urinário (10 mEq/L) e cloro urinário (130 mEq/L). Qual etiologia explica essas alterações?

- A) Acidose tubular renal do tipo 1.
- B) Acidose tubular renal do tipo 4.
- C) Cetoacidose diabética.
- D) Perdas intestinais por ileostomia.
- E) Acidose láctica.

20 - Sobre polifarmácia em idosos, assinale a alternativa correta.

- A) Diuréticos são bons substitutos de agentes anti-hipertensivos na prevenção de quedas por hipotensão postural.
- B) Agentes anticolinérgicos estão associados a efeitos como boca seca, constipação e comprometimento cognitivo a longo prazo.
- C) Antibióticos são os agentes mais comuns envolvidos em reações adversas com necessidade de busca por atendimento urgente.
- D) Inibidores de bomba de prótons devem substituir o uso prolongado de bloqueadores H₂, por estarem associados a menores riscos de pneumonia e osteoporose.
- E) Varfarina está associada a menores riscos de eventos adversos em idosos, uma vez que pode ser titulada com maior facilidade.

21 - Um paciente de 68 anos, diabético e tabagista, foi submetido a uma laparotomia exploradora devido a um abdome agudo obstrutivo por bridas. No pós-operatório, evoluiu com deiscência da ferida operatória no 8º dia. Ao exame, observou-se secreção serossanguinolenta, sem sinais evidentes de infecção. A análise laboratorial revelou albumina sérica de 2,8 g/dL e hemoglobina de 9,0 g/dL. Considerando os fatores que influenciam na cicatrização de feridas, qual é a conduta mais adequada para otimizar o processo de cicatrização desse paciente?

- A) Antibioticoterapia empírica e fechamento primário da ferida.
- B) Fechamento primário retardado com antibioticoterapia sistêmica.
- C) Manejo com terapia por pressão negativa e otimização do estado nutricional.
- D) Reabordagem cirúrgica com ressecção de bordas necróticas e sutura primária.
- E) Curativos diários a fim de promover cicatrização por segunda intenção sem necessidade de intervenção adicional.

22 - Um paciente de 77 anos, portador de neoplasia gástrica avançada, foi submetido a uma gastrectomia total com reconstrução em Y de Roux. No pós-operatório, apresentou hipoalbuminemia persistente (2,4 g/dL), perda ponderal progressiva e intolerância alimentar, com episódios de diarreia e distensão abdominal. A equipe assistente discute a melhor estratégia para otimizar o suporte nutricional desse paciente. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais apropriada.

- A) Instituir nutrição enteral precoce por jejunostomia, associada à monitorização nutricional rigorosa.
- B) Manter nutrição parenteral total prolongada até recuperação da albumina para valores acima de 3,4 g/dL.
- C) Introduzir dieta oral hipercalórica e hiperlipídica imediatamente para compensar a desnutrição.
- D) Administrar suplementação proteica via oral em pequenas porções, sem necessidade de suporte enteral.
- E) Restringir a ingestão de carboidratos e líquidos para evitar síndrome de dumping e permitir adaptação intestinal.

23 - Um paciente de 63 anos, diabético e hipertenso, foi submetido a uma colectomia direita laparoscópica eletiva por um adenocarcinoma de cólon. No terceiro dia de pós-operatório,

desenvolveu febre (38,8 °C), taquicardia (118 bpm) e dor abdominal progressiva. O exame físico revelou sinais de peritonismo no quadrante inferior direito. A tomografia computadorizada evidenciou coleção pericólica com gás e líquido heterogêneo, sugerindo abscesso intra-abdominal. Qual é a melhor abordagem terapêutica inicial?

- A) Instituir antibioticoterapia empírica de amplo espectro e observar a evolução clínica por 48 horas antes de qualquer outra intervenção.
- B) Realizar laparotomia exploradora imediata para drenagem do abscesso e lavagem da cavidade abdominal.
- C) Introduzir antibioticoterapia empírica de amplo espectro e realizar drenagem percutânea guiada por imagem do abscesso.
- D) Iniciar antibioticoterapia direcionada após coleta de hemoculturas e culturas da secreção abdominal, sem necessidade de drenagem.
- E) Suspender a antibioticoterapia, pois coleções pequenas podem ser resolvidas espontaneamente sem intervenção.

24 - Um homem de 37 anos, previamente hígido, é admitido no pronto-socorro após colisão automobilística frontal a 80 km/h (era condutor do veículo). Na chegada, apresenta-se consciente (Glasgow 13 - A4V4M5), taquicárdico (FC: 125 bpm), hipotenso (PA: 85x50 mmHg) e com respiração ofegante; vias aéreas pervias. O exame físico revela turgência jugular, murmúrio vesicular reduzido à direita e desvio traqueal para a esquerda. Qual deve ser o manejo inicial da condição apresentada pelo paciente com intuito de promover ventilação adequada?

- A) Realizar ultrassonografia FAST para confirmar hemotórax e proceder à drenagem torácica.
- B) Solicitar radiografia de tórax para avaliar pneumotórax hipertensivo e, se confirmado, instalar dreno torácico.
- C) Iniciar expansão volêmica agressiva com 2 litros de cristaloides aquecidos antes de qualquer outra intervenção.
- D) Proceder, imediatamente, à toracocentese descompressiva em quinto espaço intercostal com linha medioaxilar.
- E) Intubar o paciente, preventivamente, devido à alteração do nível de consciência antes de qualquer outra abordagem.

25 - Um homem de 28 anos, previamente hígido, é admitido no pronto-socorro de um centro de trauma após sofrer uma agressão com arma branca no hipocôndrio esquerdo. Ele está consciente, normotenso (PA: 120x80 mmHg), com leve taquicardia (FC: 105 bpm) e saturação de O₂ de 98% em ar ambiente. O exame físico revela uma ferida de, aproximadamente, 3,0 cm no hipocôndrio esquerdo, sem evisceração, e dor leve à palpação. O ultrassom FAST é negativo para líquido livre intra-abdominal. RX abdome normal. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais apropriada nessa situação.

- A) Suturar o ferimento e alta hospitalar com orientações, pois não há sinais clínicos de instabilidade ou sangramento intra-abdominal.
- B) Manter o paciente em observação por 24 horas com exames seriados de hemoglobina e reavaliações clínicas.

- C) Indicar laparotomia exploradora de urgência, visto que a ferida ocorreu em uma zona de risco.
- D) Solicitar tomografia de abdome sem contraste para avaliação de lesão de órgãos sólidos.
- E) Realizar videolaparoscopia para diagnosticar lesões diafragmáticas e possível penetração peritoneal.

26 - Um homem de 31 anos, previamente hígido, sofreu queimadura por explosão de gás enquanto realizava manutenção em um fogão. Ele chega ao pronto socorro com queimaduras de segundo e terceiro grau em face, pescoço, região anterior do tórax e ambas as mãos. Relata dificuldade respiratória leve. Ao exame, apresenta estridor inspiratório, rouquidão e fuligem em orofaringe. A saturação de O₂ em ar ambiente é de 94%, frequência respiratória de 26 irpm, frequência cardíaca de 110 bpm e pressão arterial de 125x80 mmHg. Com base nesse quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta a conduta que corresponde à prioridade número um, nesse caso.

- A) Administrar oxigênio sob máscara de não reinalação e monitorizar a evolução do quadro respiratório.
- B) Realizar intubação orotraqueal precoce para prevenir insuficiência respiratória progressiva.
- C) Prescrever corticoide sistêmico para reduzir o edema de via aérea e evitar a necessidade de intubação.
- D) Iniciar ressuscitação volêmica agressiva com ringer lactato devido à extensão das queimaduras.
- E) Avaliar a necessidade de escarotomias torácicas devido ao risco de síndrome compartimental torácica.

27 - Um paciente de 59 anos, hipertenso e diabético, foi submetido a uma pancreatoduodenectomia por adeno-carcinoma de cabeça do pâncreas. No pós-operatório imediato, foi deixado um dreno de sucção em posição retroperitoneal para monitorização de possível fístula pancreática. No terceiro dia de pós-operatório, observam-se saída de líquido de aspecto seroso, com débito de 150 mL/dia, e amilase no líquido drenado de 5.000 U/L. O paciente apresenta sinais vitais estáveis, sem sinais de sepse. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada nesse momento.

- A) Manutenção do dreno, suporte nutricional e avaliação clínica rigorosa, pois a maioria das fístulas pancreáticas pós-duodenopancreatectomia são de baixo débito e podem fechar espontaneamente.
- B) Remoção imediata do dreno, pois sua permanência aumenta o risco de infecção e não tem papel na fístula pancreática.
- C) Revisão cirúrgica imediata para fechamento da fístula, pois a alta concentração de amilase no dreno indica falha na anastomose pancreática.
- D) Substituição do dreno por um de maior calibre e maior poder de sucção para evitar o acúmulo de secreção e reduzir o risco de infecção secundária.
- E) Instalação precoce de nutrição parenteral total e antibioticoterapia empírica de amplo espectro, pois a fístula pancreática está associada a altas taxas de infecção e mortalidade.

28 - Um paciente de 44 anos, previamente hígido, apresenta disfagia progressiva a alimentos sólidos há 6 meses, sem perda ponderal significativa ou outros sintomas sistêmicos. A endoscopia digestiva alta revelou uma lesão subepitelial de 4,0 cm na parede posterior do esôfago médio, recoberta por mucosa íntegra. A ecoendoscopia demonstrou uma lesão hipoechoica bem delimitada,

com margens regulares, originada na camada muscular própria, sem sinais de invasão de estruturas adjacentes. Não foram detectadas linfonodomegalias ou metástases nos exames de imagem. Qual é a melhor conduta para esse caso?

- A) Observação clínica e acompanhamento endoscópico periódico, pois a maioria dos tumores subepiteliais do esôfago é assintomática e não requer intervenção.
- B) Biópsia endoscópica convencional para confirmação histológica, seguida de esofagectomia subtotal caso o tumor seja confirmado como benigno.
- C) Mucosectomia da lesão, pois tumores subepiteliais do esôfago médio são geralmente tratados dessa forma com baixo risco de complicações.
- D) Remoção cirúrgica ou endoscópica da lesão, pois a origem na muscular própria sugere um leiomioma, que pode evoluir com crescimento progressivo e distúrbios da deglutição.
- E) Radioterapia para redução do tamanho tumoral e alívio da disfagia, pois é um método eficaz para tratar tumores benignos do esôfago de médio porte.

29 - Homem, 58 anos, tabagista, com história de DPOC e IMC de 32 kg/m², procura atendimento devido a abaulamento em região inguinal direita há cerca de 6 meses, associado à dor leve ao esforço. No exame físico, observa-se aumento do volume na região inguinal que se acentua com a manobra de Valsava e reduz-se espontaneamente em repouso. O paciente relata episódios intermitentes de desconforto local, mas sem sinais de encarceramento ou estrangulamento. Diante desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para o tratamento cirúrgico da hérnia desse paciente.

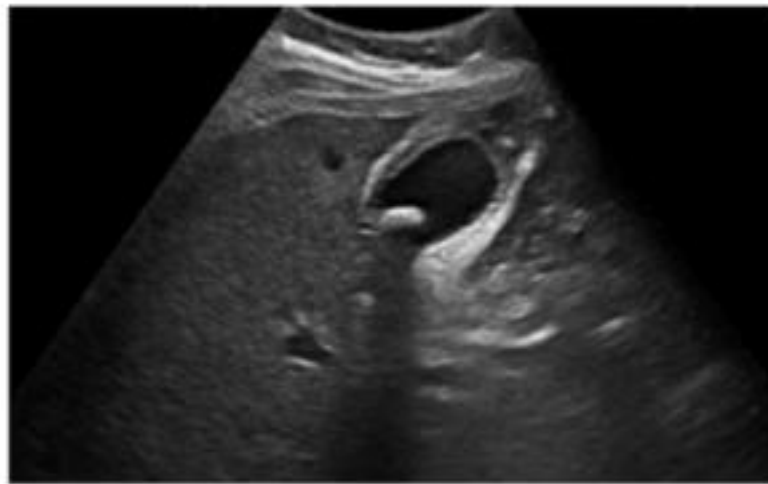
- A) Herniorrafia convencional sem tela, pois a ausência de sinais de estrangulamento dispensa material protético.
- B) Hernioplastia inguinal aberta com tela (Lichtenstein), por ser uma técnica segura e com baixa taxa de recidiva.
- C) Videolaparoscopia com abordagem transabdominal pré-peritoneal (TAPP), pois essa técnica é superior nos casos de hérnia inguinal, inclusive unilateral, e deve substituir as abordagens abertas.
- D) Acompanhamento expectante, pois hérnias inguinais sintomáticas podem ser manejadas clinicamente em pacientes sem sinais de complicação.
- E) Técnica Shouldice, por proporcionar melhor resultado funcional e menor incidência de dor crônica pós-operatória.

30 - Homem, 66 anos, hipertenso e diabético, dá entrada no pronto-socorro com dor abdominal difusa, febre (38,5 °C) e leucocitose de 19.000/mm³. Relata episódios prévios de dor no quadrante inferior esquerdo do abdome, mas nunca necessitou de internação. Ao exame físico, apresenta abdome distendido, com defesa e dor intensa à palpação profunda no quadrante inferior esquerdo, além de sinais de irritação peritoneal. A tomografia computadorizada de abdome com contraste revela espessamento da parede do cólon sigmoide, divertículos, bolhas de ar extraluminais e grande coleção líquida pericólica com bolhas de gás. Com base nesse quadro, qual é a melhor conduta inicial para esse paciente?

- A) Antibioticoterapia endovenosa e observação clínica, com reavaliação em 48 horas.
- B) Colonoscopia de urgência para confirmação diagnóstica e planejamento terapêutico.

- C) Realizar ressecção do segmento intestinal acometido pela doença com anastomose primária, mesmo em presença de peritonite difusa, pois a evolução costuma ser favorável.
- D) Drenagem percutânea da coleção guiada por imagem e antibioticoterapia direcionada.
- E) Laparotomia exploradora com ressecção segmentar do sigmoide e colostomia terminal (procedimento de Hartmann).

31 - Homem de 52 anos, com histórico de obesidade e dislipidemia, procura o pronto-socorro com dor no quadrante superior direito do abdome há 24 horas, associada a febre de 38,5 °C e náuseas. Ao exame físico, apresenta dor à palpação profunda em hipocôndrio direito. Exames laboratoriais mostram leucocitose com desvio à esquerda; bilirrubinas, fosfatase alcalina e GGT dentro dos valores de referência. A ultrassonografia abdominal está demonstrada na imagem a seguir. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta inicial para esse paciente.



(<https://radiacad.com>)

- A) Administração de antibiótico de amplo espectro e colecistectomia laparoscópica precoce (dentro de 72 horas).
- B) Uso de analgésicos e antibióticos, mantendo tratamento clínico expectante e reavaliando necessidade cirúrgica após 6 semanas.
- C) Drenagem percutânea da vesícula biliar como terapia definitiva, evitando cirurgia devido ao risco de complicações.
- D) Administração de antibióticos e realização de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) como abordagem primária.
- E) Antibioticoterapia isolada, seguida de colecistectomia laparoscópica tardia após 4 a 6 semanas.

32 - Uma gestante de 24 semanas apresenta dor abdominal em quadrante inferior direito há 18 horas, associada a febre de 38 °C e náuseas. O exame físico revela dor à palpação no quadrante inferior direito, mas sem sinais peritoneais marcantes. A ultrassonografia é inconclusiva. Assinale a alternativa que apresente a conduta mais apropriada.

- A) Solicitar ressonância magnética (RM) para confirmação diagnóstica.
- B) Indicar apendicectomia laparoscópica de urgência sem confirmação diagnóstica, mesmo com quadro clínico duvidoso e ultrassonografia inconclusiva.

- C) Administrar antibióticos e observar evolução.
- D) Solicitar tomografia computadorizada para confirmação.
- E) Esperar a resolução espontânea da dor.

33 - Durante a preparação para uma cirurgia eletiva de gastrectomia subtotal, a primeira do dia, um residente de cirurgia de primeiro ano inicia a escovação cirúrgica com uma escova embebida em solução de clorexidina a 2%. No entanto, ele passa mais de 10 minutos esfregando vigorosamente as mãos e antebraços, causando eritema difuso em sua pele. O cirurgião preceptor observa a técnica e o orienta quanto às melhores práticas de antisepsia pré-operatória. Com base nas diretrizes atuais sobre escovação cirúrgica, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta a ser adotada.

- A) O residente deve continuar esfregando vigorosamente as mãos e os antebraços por, no mínimo, 15 minutos para garantir a máxima remoção de patógenos.
- B) A escovação deve ser substituída por fricção com álcool a 70% comum, aplicado com gaze cirúrgica, suficiente para eliminar a flora bacteriana das mãos antes da cirurgia.
- C) O tempo de escovação deve ser reduzido para 2 a 5 minutos, com movimentos sistemáticos, evitando o excesso de fricção para prevenir lesões cutâneas que podem aumentar o risco de contaminação.
- D) O uso de escova rígida na escovação das mãos é essencial para garantir a remoção adequada da flora bacteriana residente e transitória, devendo ser realizada antes de cada procedimento.
- E) A paramentação deve ser realizada antes da escovação cirúrgica, permitindo a redução do risco de contaminação do avental e das luvas estéreis durante o procedimento.

34 - Durante uma apendicectomia aberta, em um paciente obeso, um residente de cirurgia precisa realizar a dissecação e ligadura cuidadosa da artéria apendicular. Ele solicita ao instrumentador uma pinça de Halsted, mas o cirurgião preceptor recomenda outro instrumento, argumentando que a escolha inadequada pode aumentar o risco de trauma tecidual e sangramento. Dos instrumentos relacionados a seguir, o mais apropriado para a dissecação e ligadura da artéria apendicular nesse contexto é a pinça:

- A) Duval.
- B) Mixer.
- C) Kocher.
- D) Allis.
- E) Jansen.

35 - Um homem de 58 anos, portador de DPOC grave e uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para osteoartrite, procura atendimento por dor epigástrica intensa e súbita, associada a sudorese e náuseas. Ao exame físico, encontra-se em regular estado geral, febril (T: 38,3°C), taquicárdico (FC = 122 bpm), com pressão arterial de 91x64 mmHg e abdome doloroso à palpação, com defesa voluntária. A radiografia de abdome em ortostase não demonstra pneumoperitônio evidente. Lactato sérico: 7,8 mmol/L (valores de referência: 0,5 a 1,6 mmol/L). Diante desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais apropriada.

- A) Iniciar inibidor de bomba de prótons endovenoso e antibioticoterapia, com observação clínica.
- B) Indicar endoscopia digestiva alta com biópsia para pesquisa de *H. Pylori* e em caso positivo, indicar terapia para erradicação do mesmo.
- C) Realizar laparotomia exploradora para fechamento da úlcera perfurada e lavagem da cavidade.
- D) Realizar tomografia computadorizada de abdome para melhor caracterização da perfuração.
- E) Realizar tratamento conservador com jejum, hidratação venosa e repetir o RX de abdome em 3 posições.

36 - Uma mulher de 72 anos, hipertensa e diabética, é admitida no pronto socorro com dor abdominal difusa de início súbito, acompanhada de diarreia sanguinolenta. Relata episódio de hipotensão há 12 horas, secundário ao uso de diuréticos. Ao exame, está hemodinamicamente estável, com dor à palpação no quadrante inferior esquerdo e ausência de sinais de irritação peritoneal. Os exames laboratoriais mostram leucocitose moderada e discreta acidose metabólica. A tomografia computadorizada de abdome com contraste evidencia espessamento parietal do cólon esquerdo e pneumatose intestinal leve, sem sinais de perfuração ou pneumatose portal. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para essa paciente.

- A) Antibioticoterapia empírica e suporte clínico, com avaliação cirúrgica caso haja piora clínica.
- B) Colectomia subtotal de urgência devido à pneumatose intestinal, indicando necrose transmural.
- C) Angiografia mesentérica para possível embolização arterial e revascularização do cólon.
- D) Colonoscopia emergencial para descompressão e possível abordagem endoscópica da lesão.
- E) Laparotomia exploradora imediata para ressecção segmentar do cólon isquêmico.

37 - Um homem de 49 anos, com histórico de retocolite ulcerativa em uso de mesalazina, com sintomas controlados por longo período, mas com episódios recentes de tenesmo, sangramento retal e constipação crônica, procura atendimento por sangramento intermitente e prurido anal há seis meses. Ele relata que o sangramento ocorre tipicamente após a evacuação e nota a presença de tecido prolapsado que retorna espontaneamente para o canal anal. Nega dor intensa ou secreção purulenta. Ao exame físico, observam-se hemorroidas internas de grau II. Qual é a melhor abordagem terapêutica para esse paciente?

- A) Escleroterapia com injeção de agente esclerosante.
- B) Hemorroidectomia convencional aberta (técnica de Milligan-Morgan).
- C) Uso de venotônicos e pomadas tópicas à base de corticosteroides.
- D) Desarterialização hemorroidária transanal guiada por Doppler.
- E) Ligadura elástica das hemorroidas.

38 - Uma mulher de 46 anos, previamente hígida, é submetida a uma ultrassonografia abdominal de rotina, que revela uma lesão hepática sólida, hiperecogênica, de 16 cm, localizada no lobo direito do fígado. Ela está assintomática e não tem histórico de hepatopatia ou consumo de anabolizantes. Como parte da investigação, é solicitada uma tomografia computadorizada (TC) trifásica do abdome, cuja imagem é reproduzida a seguir:



Fase arterial



Fase tardia

(<https://radiopaedia.org>)

Com base no caso clínico e nas imagens, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- A) Adenoma hepatocelular.
- B) Hiperplasia nodular focal.
- C) Hemangioma hepático.
- D) Colangiocarcinoma intra-hepático.
- E) Metástase hepática de tumor neuroendócrino.

39 - Homem de 52 anos, etilista crônico, apresenta dor epigástrica recorrente há 3 anos, com piora progressiva e irradiação para o dorso. Relata perda de peso e esteatorreia nos últimos meses. Durante a investigação, foi realizada uma tomografia computadorizada (TC) de abdome que evidenciou atrofia pancreática, dilatação irregular do ducto pancreático e calcificações intraparenquimatosas. Com base no quadro clínico e nos achados de imagem, qual é a melhor conduta inicial para o manejo desse paciente?

- A) Abstenção alcoólica, analgesia com opioides e pancreatectomia parcial precoce.
- B) Suspensão do consumo de álcool, reposição enzimática pancreática e analgesia escalonada.
- C) Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) de rotina para drenagem do ducto pancreático.
- D) Ressecção cirúrgica precoce devido ao risco elevado de malignização.
- E) Radioterapia pancreática para controle da dor e regressão da inflamação crônica.

40 - Um homem de 35 anos, previamente hígido, procura atendimento médico devido a um nódulo cervical indolor, de crescimento lento, localizado na região submandibular direita. O exame físico revela uma massa de consistência fibroelástica, bem delimitada e móvel, sem sinais flogísticos. A ultrassonografia cervical mostra uma lesão hipoeoica, homogênea, sem sinais de infiltração nos planos profundos. A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) sugere um tumor de origem glandular. Com base na hipótese diagnóstica mais provável, qual é a melhor conduta para esse paciente?

- A) Acompanhamento clínico com ultrassonografias seriadas.
- B) Quimioterapia neoadjuvante seguida de ressecção cirúrgica.
- C) Terapia antibiótica empírica para linfadenite bacteriana submandibular.
- D) Radioterapia isolada para controle do crescimento tumoral.
- E) Indicação cirúrgica para excisão completa da lesão.

41 - Um recém-nascido de 10 dias de vida é levado ao Pronto-Socorro infantil por apresentar perda de peso significativa, vômitos frequentes e aceitação insatisfatória da dieta. O bebê nasceu com 3.550 g e, na avaliação atual, pesa 3.010 g. Os pais relatam que o bebê tem estado letárgico e inquieto. Na avaliação inicial, o recém-nascido encontra-se em regular estado geral, apresentando sinais de desidratação grave. Os sinais vitais revelam taquicardia e taquipneia, enquanto a pele exibe livedo reticular. Ao exame físico, observa-se um falo de 1,5 cm de comprimento e presença de estruturas que se assemelham a lábios fusos, sem gônadas palpáveis na bolsa escrotal ou nos grandes lábios. Considerando a principal hipótese diagnóstica, deve-se realizar, além dos cuidados iniciais para o quadro de choque, as seguintes medidas:

- A) Solicitar glicemia capilar, hemograma, radiografia de tórax, enzimas hepáticas e culturas, introduzindo-se, rapidamente, antibioticoterapia de amplo espectro.
- B) Solicitar glicemia plasmática, insulina, anticorpo anti-ilhota e anti-GAD, para introdução rápida de insulina subcutânea, se necessário.
- C) Não realizar exames complementares a princípio; paciente apresenta perda ponderal esperada no recém-nascido. Tratar apenas a desidratação e avaliar a técnica de amamentação.
- D) Solicitar sódio plasmático, potássio plasmático, gasometria, glicemia e checar resultado do teste do pezinho; há provável necessidade de introdução de hidrocortisona.
- E) Solicitar glicemia capilar, hemograma e dosagem de hormônios tireoidianos; administrar levotiroxina para correção de hipotireoidismo congênito suspeito.

42 - Escolar, sexo masculino, 8 anos, é admitido na emergência pediátrica com quadro de febre alta, taquicardia, taquipneia e confusão mental. Nas últimas 24 horas, a mãe notou que ele estava gradualmente mais sonolento e ficou mais pálido. Sinais vitais na admissão: frequência cardíaca de 145 bpm; frequência respiratória de 38 irpm; pressão arterial de 85x55 mmHg; e temperatura de 39.5 °C. Escala de Coma de Glasgow de 11. Exames laboratoriais iniciais revelam leucocitose com neutrofilia, plaquetopenia, acidose metabólica e lactato elevado. Com base nos novos critérios propostos em 2024 com o *Phoenix Sepsis Score*, assinale a afirmativa correta quanto ao que melhor define o diagnóstico nesse paciente.

- A) Presença de febre e taquicardia isoladas, sem necessidade de disfunção orgânica, já define SIRS (síndrome de resposta inflamatória sistêmica); se houver foco infeccioso associado, a criança tem sepse grave.
- B) Rebaixamento de nível de consciência e taquicardia, sem alteração na pressão arterial, descarta a possibilidade de sepse.
- C) Lactato não é um parâmetro utilizado para o diagnóstico de sepse em Pediatria.
- D) Sepse é diagnosticada por evidência de infecção suspeita ou confirmada e disfunção orgânica aguda, como alterações neurológicas e da coagulação.
- E) O diagnóstico de sepse grave requer apenas a presença de febre persistente e elevações

laboratoriais como lactato elevado, independentemente do estado mental ou de sinais de perfusão.

43 - Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados iniciais com a pele de um recém-nascido, de acordo com as orientações mais recentes da Sociedade Brasileira de Pediatria.

- A) O "primeiro banho" deve ser realizado idealmente por volta da sexta hora de vida.
- B) É obrigatório o uso de álcool 70% para a limpeza do coto umbilical de um recém-nascido cujo parto foi hospitalar.
- C) Cremes hidratantes não devem ser utilizados em recém-nascidos.
- D) O banho do recém-nascido pode ser realizado com um sabonete ácido.
- E) Somente se deve utilizar água no banho e na limpeza da região das fraldas do bebê para a retirada de sujidades.

44 - Escolar, 5 anos de idade, apresenta lesões cutâneas pruriginosas, formando túneis, com pequenas vesículas e crostas, acometendo região interdigital, abdômen inferior e axilas. Tem antecedente de dermatite atópica. Frequenta escola, mora somente com a mãe, que não apresenta nenhum sintoma. Assinale a alternativa que contém o tratamento mais indicado para essa criança.

- A) Tiabendazol tópico, associado ao albendazol, por via oral.
- B) Anti-histamínico de segunda geração e creme hidratante tópico.
- C) Corticosteroide associado ao cetoconazol, por via tópica.
- D) Anti-histamínico tópico e permetrina loção 1%.
- E) Permetrina loção a 5%.

45 - Lactente, sexo masculino, 24 meses, apresenta diarreia aquosa e em grande volume há 36 horas. Há 12 horas sem diurese, é levado por sua mãe para atendimento na Emergência. Ao exame físico, com extremidades frias, sonolento, pulso filiforme, perfusão periférica de 5 segundos, olhos encovados e mucosa ressecada. Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa que contém a terapêutica inicial mais adequada para esse paciente, de acordo com as orientações mais atuais do Ministério da Saúde.

- A) Se o paciente não estiver vomitando, deve-se prescrever solução de sais de reidratação oral, 50 mL/kg para ser administrada via oral em 4 horas.
- B) Deve-se realizar expansão volêmica com soro fisiológico 0,9%, 30 mL/kg, para correr em 30 minutos.
- C) Deve-se realizar expansão volêmica com solução Ringer-lactato, 30 mL/kg, para correr em 1 hora.
- D) Deve-se realizar hidratação venosa com soro fisiológico 50 mL/kg, associada a cloreto de potássio, para ser administrada em 1 hora.
- E) Deve-se realizar expansão volêmica com solução Ringer-lactato, 100 mL/kg em 6 horas.

46 - Lactente, sexo feminino, 16 meses, comparece à consulta de puericultura, trazida por sua mãe, que tem preocupações com relação ao crescimento e desenvolvimento. Mãe realizou pré-natal com 5 consultas médicas, e a criança nasceu com 32 semanas de idade gestacional, de parto cesáreo devido à doença hipertensiva específica da gravidez, pesando 2.100g. Recebeu aleitamento

materno exclusivo até os 6 meses de idade e, atualmente, intercala leite materno e fórmula de seguimento, faz duas refeições principais semelhantes às da família e frutas nos lanches. O peso é 11 kg (entre o escore-z +1 e +2), estatura de 75 cm (entre o escore-z -1 e 0). Não anda, engatinha, fica em pé com apoio, apanha e aponta objetos, bate palmas, fala "não". Em relação ao caso descrito, assinale a afirmativa correta, de acordo com as recomendações atuais do Ministério da Saúde e que constam na caderneta da criança.

- A) O bebê apresenta atraso no desenvolvimento, devendo ser encaminhado para terapia ocupacional e fisioterapia.
- B) O lactente está eutrófico e com provável atraso de desenvolvimento para a idade, devendo-se marcar retorno em 2 semanas, após estimulação, para observar se a criança já está andando.
- C) O bebê está com sobrepeso e atraso no desenvolvimento, devendo ser encaminhado para nutricionista e avaliação neuropediátrica.
- D) A criança apresenta desenvolvimento normal com fator de risco, devendo ser informado à mãe a importância da estimulação da criança.
- E) O bebê apresenta sobrepeso e desenvolvimento normal, devendo ser ajustada a alimentação e seguir com acompanhamento de rotina.

47 - Escolar, sexo masculino, 5 anos de idade, contactante de adulto recém diagnosticado com tuberculose, em tratamento supervisionado há 45 dias. A criança encontra-se assintomática, com teste tuberculínico com enduração de 7 mm e radiografia de tórax normal. Em relação a esse paciente, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) Repetir o teste tuberculínico em cerca de 8 semanas.
- B) Realizar broncoscopia para pesquisa de BAAR.
- C) Iniciar tratamento de infecção latente.
- D) Iniciar esquema tríplice para tratamento de tuberculose.
- E) Dar alta, pois o familiar já está há mais de 15 dias em tratamento.

48 - Escolar, 9 anos e 8 meses, sexo masculino, é levado ao médico pelos pais por causa de dores crônicas de cabeça. Suas dores de cabeça começaram no início do ano letivo anterior. Naquele ano, as dores de cabeça ocorriam em toda a cabeça, durante quase metade dos dias letivos, mas não ocorriam nos fins de semana. Naquela época, ele não se queixava de nenhuma sensibilidade associada à luz ou ao som, alterações na visão, "formigamentos" ou fraqueza muscular. As dores de cabeça melhoraram durante o verão, mas, no início deste ano letivo, as dores de cabeça retornaram. Agora ocorrem na parte frontal e superior da cabeça na maioria dos dias. A criança nega quaisquer sintomas associados. O ibuprofeno (dose adequada) "ajuda um pouco". No exame neurológico, há leve oscilação ao andar quando testada com um pé a frente do outro. Sua mãe relata que teve enxaqueca na idade dele. O menino também relata dores de cabeça "por sorvete"; não apresenta nenhuma doença de base. Qual dos seguintes achados é indicativo, com maior probabilidade, de que esse paciente tenha uma cefaleia secundária?

- A) A duração da dor de cabeça.
- B) A localização da dor de cabeça.
- C) A resposta da dor de cabeça à medicação.

- D) A existência de dores de cabeça por sorvete.
- E) O resultado do exame neurológico.

49 - Assinale a alternativa correta a respeito de vacinação, de acordo com as recentes atualizações propostas pelo Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações.

- A) Lactente de 9 meses que não recebeu nenhuma dose de vacina oral contra o rotavírus, agora pode receber a primeira dose dessa vacina.
- B) Recém-nascido, que residirá com adulto recém-diagnosticado de tuberculose pulmonar agora pode receber a vacina a BCG concomitantemente ao uso de quimioprofilaxia primária.
- C) Crianças irão receber todas as doses de vacina contra a poliomielite na forma do imunizante inativado, aos 2, 4, 6, 15 meses e 4 anos de idade.
- D) A vacinação contra influenza para crianças menores de 6 anos estará apenas nas campanhas realizadas durante os meses de maior circulação do vírus.
- E) A vacina conjugada 15-valente contra o pneumococo passa a ser administrada para todos os lactentes abaixo de 2 anos, em um esquema de 3 doses básicas mais um reforço.

50 - Escolar, sexo masculino, 8 anos de idade, é levado à unidade de pronto atendimento com dor abdominal intensa e febre intermitente nos últimos dois dias. O paciente apresentou um quadro gripal há cerca de uma semana, tendo utilizado somente antitérmicos. Ao exame físico, apresenta algumas petéquias e púrpuras palpáveis localizadas nos membros inferiores e nas nádegas, bilateralmente, além de discreto edema nos tornozelos e dor em uma das articulações dos joelhos. A dor abdominal é difusa e melhora pouco com uso de paracetamol. Nos exames laboratoriais, evidencia-se uma proteinúria discreta com hematúria microscópica. A hipótese diagnóstica, com justificativa correta para o caso, é:

- A) Doença de Kawasaki; presença de febre, exantema petequial e envolvimento articular.
- B) Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica; quadro infeccioso pregresso e hematúria.
- C) Artrite reumatoide juvenil; presença de febre, edema articular e artralgia.
- D) Lúpus eritematoso sistêmico juvenil; artralgia e achados urinários.
- E) Vasculite por imunoglobulina A; púrpura palpável, dor abdominal e achados urinários.

51 - Escolar, 5 anos, sexo masculino, é levado ao Pronto-Socorro, em um plantão noturno, por sua mãe, que relata que a criança introduziu um objeto no nariz enquanto brincava, mexendo em uma caixa de pequenos brinquedos. Mãe não sabe qual objeto e diz que sabe apenas o que a criança reclamou para ela. O paciente apresenta parcial obstrução nasal à direita, sem outros sintomas significativos. Na avaliação ectoscópica das narinas anteriores, o corpo estranho não é visto. Radiografia dos seios da face revela uma imagem radiopaca circular com duplo contorno (duplo halo) na fossa nasal direita. Nesse caso, qual é a conduta correta?

- A) Alta médica, com encaminhamento para consulta com otorrinolaringologista, em avaliação de rotina, que dispõe de material mais específico para remoção.
- B) Transferência para um centro de referência, onde possa ser realizada uma nasofibrosopia mais rapidamente, para remoção.
- C) Lavagem nasal com alta pressão e volume para tentar mobilizar o corpo-estranho.

D) Administração de vasoconstrictor tópico com anestésico para tentativa de retirada com pinça, às cegas.

E) Uso de alto fluxo de ar comprimido na narina contralateral, após sedação da criança, para mobilização do corpo estranho.

52 - Lactente, sexo masculino, 8 meses, é trazido ao Pronto-Socorro com quadro de tosse, dificuldade respiratória e chiado no peito há dois dias. O exame físico revela uma frequência respiratória de 50irpm, tiragem intercostal e sibilos difusos à ausculta pulmonar. A saturação de oxigênio em ar ambiente está 91%. A mãe relata que a criança teve contato com um irmão mais velho que recentemente apresentou sintomas de infecção do trato respiratório superior. Com base no quadro clínico e na história, o diagnóstico de bronquiolite é estabelecido. Qual é o tratamento correto para esse paciente, considerando as diretrizes atuais?

A) Administrar antibióticos orais para prevenir infecção bacteriana secundária.

B) Iniciar corticosteroide inalatório para reduzir a inflamação das vias aéreas.

C) Oferecer suporte, com oxigenoterapia, e cuidados com a hidratação, observando a evolução clínica.

D) Terapia com broncodilatadores nebulizados a cada 3 ou 4 horas, inicialmente.

E) Introduzir oseltamivir, realizar prova terapêutica com salbutamol inalatório e dose única de corticoterapia parenteral.

53 - Com relação à suplementação profilática de ferro em lactentes, qual das seguintes afirmações é correta, considerando as diretrizes atuais da Sociedade Brasileira de Pediatria e o conhecimento sobre prevenção de anemia ferropriva?

A) Lactentes nascidos a termo e sem fatores de risco para anemia, independentemente do tipo de alimentação, devem iniciar suplementação de ferro a partir dos seis meses para prevenção da carência nutricional de ferro.

B) Lactentes amamentados exclusivamente, mesmo que prematuros, não necessitam de suplementação de ferro até os 3 meses de idade, pois o leite materno contém quantidades adequadas de ferro biodisponível para prevenir anemia nessa fase.

C) Lactentes alimentados exclusivamente com fórmula infantil não necessitam de suplementação de ferro adicional até os 12 meses de idade, visto que as fórmulas infantis são fortificadas com ferro suficiente para atender às necessidades diárias.

D) A suplementação profilática de ferro deve ser iniciada em todos os lactentes a termo a partir de 3 meses de idade, independentemente do método de alimentação, para garantir o adequado desenvolvimento cognitivo e prevenir anemia ferropriva.

E) A suplementação profilática de ferro é, hoje, prática individualizada para cada lactente e, portanto, lactentes que têm sua alimentação complementar adequada, não devem receber ferro medicamentoso.

54 - Lactente, sexo masculino, 12 meses de idade, apresenta exantema maculopapular não pruriginoso, que se iniciou no tronco e, em 12 horas, evoluiu para face, pescoço e coxas. Não há adenomegalias. Vinha apresentando, há cerca de 72 horas febre alta (38,5 a 39 graus) e irritabilidade. O último pico febril foi há 24 horas e a criança está em bom estado geral. Qual é o

diagnóstico mais provável?

- A) Dengue.
- B) Escarlatina.
- C) Febre maculosa.
- D) Exantema súbito.
- E) Eritema infeccioso.

55 - Lactente, sexo feminino, 6 meses, apresenta-se em parada cardiorrespiratória (PCR) em uma enfermaria pediátrica. A equipe prontamente iniciou as manobras de reanimação conforme as diretrizes da *American Heart Association* (AHA) para pediatria. Considerando as recomendações mais recentes sobre a técnica da reanimação cardipulmonar em lactentes, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta.

- A) As compressões torácicas devem ser realizadas imediatamente após a realização das ventilações de resgate que iniciam a reanimação pediátrica; não deve haver interrupção nas compressões, até a criança esboçar movimentos compatíveis com a vida.
- B) Para lactentes, recomenda-se a utilização da técnica de compressão torácica com duas mãos envolvendo o tórax, aplicando-se compressões com uma frequência de, pelo menos, 120 movimentos por minuto.
- C) As compressões torácicas em lactentes devem ser realizadas com o socorrista posicionando uma mão sobre a outra no centro do tórax do lactente, entre os mamilos, assegurando uma profundidade de compressão de, pelo menos, 5 a 6 cm.
- D) A técnica de compressão torácica recomendada para lactentes envolve o uso de dois dedos para compressões ou dois polegares para socorristas que não conseguem alcançar uma profundidade adequada com a técnica de dois dedos, visando uma profundidade de um terço do diâmetro do tórax, aproximadamente, 4 cm.
- E) Após a obtenção da via aérea avançada (intubação), a frequência deverá ser de 12 a 20 ventilações por minuto.

56 - Os pais de um lactente do sexo feminino, com 3 meses de idade, referem preocupação sobre o crescimento de sua filha que "não está evoluindo conforme imaginavam". Nascida a termo, com 39 semanas, comprimento = 50 cm, peso = 3.000 g, perímetro cefálico (PC) de 34 cm. No exame atual: peso = 4.600 g; estatura de 58 cm; e perímetro cefálico de 40 cm. O bebê está em aleitamento materno exclusivo. Ao que se refere a essa criança, assinale a alternativa correta.

- A) Está crescendo adequadamente, segundo os ganhos de peso, estatura e PC esperados para a idade.
- B) O ganho de peso esperado por dia está abaixo do adequado para a idade.
- C) Ganhou muito peso para a idade e cresceu adequadamente em estatura; entretanto, o PC está aquém do esperado para a idade.
- D) Apresenta peso e estatura adequados, porém, já ao nascimento, apresentou PC baixo, compatível com microcefalia.
- E) Não cresceu bem em estatura, embora tenha o ganho ponderal adequado.

57 - Lactente, 8 meses, sexo feminino, é trazido ao pronto atendimento com febre (38,5 - 38,8 graus), irritabilidade e recusa alimentar. Ao exame físico, estava em bom estado geral, eupneico, com hiperemia de orofaringe. A otoscopia apresentava abaulamento da membrana timpânica, bilateralmente. Não possui doenças pregressas e não fica em creche. A respeito dessa condição, é correto afirmar:

- A) Devido à prevalência de pneumococos resistentes à penicilina, a cefalosporina oral de terceira geração deve ser a escolha inicial de antibioticoterapia.
- B) Deve-se introduzir apenas um anti-inflamatório por via oral, para tratar a dor e o desconforto da criança, corroborando a ideia de evitar o uso de antibioticoterapia, que fica restrito apenas para os casos graves.
- C) A amoxicilina é o antibiótico de escolha para essa infecção e deve ser prescrita para esse bebê.
- D) O agente mais relacionado aos quadros associados de dor de garganta e otites é o *Mycoplasma pneumonia*, para o qual deve ser direcionado o tratamento antibiótico desse bebê.
- E) Não há critério para o diagnóstico de otite nessa criança, pois não há descrição da opacificação da membrana timpânica; o abaulamento não é um critério sensível para o diagnóstico dessa infecção nessa faixa etária.

58 - Sobre a vacinação para HPV (papiloma virus humano) para adolescentes, é correto afirmar:

- A) Somente adolescentes do sexo feminino podem receber a vacina após os 9 anos de idade; os meninos podem receber após os 12 anos de idade.
- B) Trata-se de uma vacina com o vírus atenuado que não pode ser administrado para um adolescente imunossuprimido.
- C) Está recentemente disponível para adolescentes com mais de 15 anos que fazem profilaxia pré-exposição para o HIV.
- D) O esquema básico até 14 anos, de acordo como Programa Nacional de Imunizações, é de 2 doses.
- E) A vacina disponível no Programa Nacional de Imunizações protege contra nove tipos de HPV.

59 - Escolar, sexo feminino, 7 anos de idade, é acompanhada na Unidade Básica de Saúde, há cerca de 4 anos, pelo pediatra que sempre a considerou alegre, sociável e comunicativa. Há 15 dias, veio à consulta trazida pelo pai com queixa de "dor de barriga", e o pediatra percebeu que ela ficou calada durante toda a consulta, quase não deixando o médico examiná-la. Há 2 dias, uma das avós da criança comunicou o médico, extremamente preocupada, que tomou conhecimento de algumas fotos íntimas (com a criança sem roupa) que estavam circulando nas redes sociais. Diante dessa situação, além da avaliação clínica da criança, o médico deve, de acordo com a legislação vigente:

- A) Anotar no prontuário a suspeita de abuso e comunicar à delegacia de polícia mais próxima da Unidade Básica de Saúde.
- B) Confrontar as informações sugeridas pela avó com a mãe e o pai, checando sua veracidade e identificando o real responsável pela atitude violenta contra a criança.
- C) encaminhar a criança para o Instituto Médico Legal mais próximo da Unidade Básica de Saúde, para realização de perícia ginecológica mais especializada.

- D) Registrar as informações no prontuário, realizar notificação de violência ao Conselho Tutelar da região onde a criança mora e preencher ficha de notificação de agravos de notificação compulsória.
- E) Anotar no prontuário suas interpretações pessoais, alertar os pais sobre os cuidados de saúde e de proteção para a criança e fazer denúncia anônima para a polícia.

60 - Pré-escolar, 3 anos, sexo masculino, internado em uma unidade de terapia intensiva pediátrica com neoplasia de sistema nervoso central, foi operado pela neurocirurgia com retirada parcial da lesão há 3 meses, e desde então vem realizando tratamento quimioterápico. Ressonância magnética recente mostra aumento importante do tumor e a equipe de oncologia pediátrica considera que não há mais possibilidades terapêuticas para tratamento do tumor. O paciente permanece acamado, pouco responsivo e acompanhado de seus pais, com oxigênio suplementar em cateter. A equipe reúne-se para definir quais condutas terapêuticas serão realizadas nesse paciente. Nesse caso, após conversar com a família, a conduta a ser adotada deve ser:

- A) Administrar opioides para controle da dor e, junto da família, orientar a não realização de ressuscitação cardiopulmonar, caso ocorra a parada cardiorrespiratória.
- B) Realizar sedação e intubação orotraqueal para maior conforto, e orientar a não realização de ressuscitação cardiopulmonar, caso ocorra a parada cardiorrespiratória.
- C) Iniciar um novo ciclo de quimioterapia com medicações diferentes das que já foram utilizadas, para controle da proliferação celular tumoral.
- D) Solicitar nova abordagem pela equipe de neurocirurgia para retirada de parte da lesão, o que aliviará a pressão intracraniana e prolongará a sobrevida.
- E) Suspende antibióticos, drogas vasoativas, hidratação parenteral, analgesia e oxigenioterapia, mantendo-se apenas a sedação da criança.

61 - R.N.B., 24 anos, secundípara, 2 partos normais anteriores, no 45º dia de pós-parto, vem ao consultório ginecológico solicitando um método anticoncepcional. Paciente em amamentação materna exclusiva. Comorbidades: IMC 32 kg/m². Alega ciclos menstruais hipermenorreicos e dismenorreia moderada. Assinale a alternativa que apresenta o método anticoncepcional mais indicado para o caso.

- A) Estrogênio mais progesterona via oral, sem pausa.
- B) Dispositivo intrauterino de cobre.
- C) Dispositivo intrauterino de levonorgestrel.
- D) Anel vaginal.
- E) Adesivo transdérmico.

62 - T.G.F., 32 anos, GII PI (1C) A0, idade gestacional cronológica de 8 semanas, deu entrada no pronto-socorro obstétrico referindo início de dor súbita em hipogástrio há cerca de 40 min. Alega sangramento vaginal escuro em pequena quantidade há 7 dias. Ao exame físico: FC: 96 bpm, PA:100x70 mmHg. Assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial mais indicada.

- A) Tomografia de abdome total.
- B) RNM de pelve.
- C) Raio-X de abdome total.

- D) Ultrassom transvaginal.
- E) Ultrassom transabdominal.

63 - T.G.F., 32 anos, GII PI (1C) A0, idade gestacional cronológica de 8 semanas, deu entrada no pronto-socorro obstétrico referindo início de dor súbita em hipogástrio há cerca de 40 min. Alega sangramento vaginal escuro em pequena quantidade há 7 dias. Ao exame físico: FC: 96 bpm, PA:100x70 mmHg. A paciente foi submetida ao beta HCG quantitativo: 5.200 mUI/mL. Hb 12 g/dL; fibrinogênio 250 mg/dL. À imagem: pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco posterior. Não identificado ecoembrionário. Identificada imagem em região anexial direita, heterogênea de 5,5 cm de diâmetro. Ecoendometrial de 16 mm. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta corretos.

- A) Torção de ovário; laparotomia exploradora.
- B) Cisto de corpo lúteo hemorrágico; controle de dor e de hemoglobina.
- C) Gestação ectópica íntegra; controle de hemoglobina.
- D) Gestação ectópica íntegra; metotrexato IM.
- E) Gestação ectópica rota; videolaparoscopia.

64 - F.G.J., 39 anos, GIII PO All, deu entrada no pronto-socorro ginecológico queixando-se de sangramento vaginal em pequena quantidade, vermelho vivo, associado à dor tipo cólica em região de abdome inferior. Idade gestacional cronológica de 6 semanas. Ao exame físico: paciente estável hemodinamicamente. Exame especular: pequena quantidade de sangue vermelho vivo coletado em fórnice posterior. Toque vaginal bimanual: colo impérvio, amolecido, fundo uterino intrapélvico. Anexos não palpáveis. Somente pelo exame físico e história clínica, assinale a alternativa que representa o diagnóstico mais provável.

- A) Aborto incompleto.
- B) Aborto completo.
- C) Ameaça de abortamento.
- D) Sangramento de colo uterino por provável pólipos endocervical.
- E) Mola hidatiforme.

65 - No decorrer do desenvolvimento gestacional, imagens ultrassonográficas diferentes vão surgindo ao longo do tempo. Em relação à ordem cronológica do aparecimento desses sinais ecográficos, assinale a alternativa correta.

- A) Saco gestacional, espessamento do ecoendometrial, vesícula vitelínica, ecoembrionário e batimentos cardíacos.
- B) Saco gestacional, espessamento do ecoendometrial, ecoembrionário, vesícula vitelínica, batimentos cardíacos.
- C) Espessamento do ecoendometrial, saco gestacional, vesícula vitelínica, ecoembrionário e batimentos cardíacos.
- D) Vesícula vitelínica, ecoembrionário, batimentos cardíacos, espessamento embrionário, saco gestacional.
- E) Ecoembrionário, batimentos cardíacos, vesícula vitelínica, saco gestacional e espessamento do

ecoendometrial.

66 - G.B.N., 31 anos, GV PIII (1N 2C) AI, idade gestacional por ultrassom precoce de 34 semanas, deu entrada ao pronto-socorro obstétrico com queixa de perda de líquido há cerca de 1 hora. Refere dor tipo contração uterina. Ao exame físico: toque vaginal: colo uterino 7cm, médio, medianizado, bolsa rota. Especular: saída de líquido claro sem grumos pelo orifício externo do colo. Cardiotocografia: normal. Paciente com sorologias negativas. De acordo com o caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) Ampicilina dose de ataque e parto cesariano.
- B) Inibição do trabalho de parto com terbutalina para antibioticoprofilaxia por 24 horas.
- C) Inibição do trabalho de parto para antibioticoprofilaxia e corticoide IM.
- D) Ampicilina dose de ataque e condução do trabalho de parto.
- E) Corticoide IM e condução do trabalho de parto com ocitocina, se necessário.

67 - D.B.G., 28 anos, primigesta, idade gestacional de 10 semanas, vem à segunda consulta pré-natal com resultado de glicemia de jejum de 92 mg/dL, solicitado na primeira consulta. De acordo com o caso, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de diabetes gestacional.
- B) Há de se solicitar teste oral de tolerância à glicose com idade gestacional entre 24-28 semanas.
- C) Há de se solicitar insulina de jejum para complementação diagnóstica.
- D) Se a hemoglobina glicada for normal, descarta-se possibilidade de diabetes.
- E) HOMA IR é essencial para o diagnóstico de diabetes gestacional, independentemente da glicose de jejum.

68 - C.N.B., 38 anos, primigesta, gestação gemelar dicoriônica e diamniótica, idade gestacional de 23 semanas, veio à Medicina Fetal para ultrassom morfológico de segundo trimestre. Nega comorbidades. Assinale a alternativa que apresenta marcadores importantes de avaliação em um ultrassom morfológico de segundo trimestre.

- A) Doppler de artéria cerebral média, translucência nuchal e medida do colo uterino via transabdominal.
- B) Doppler de artérias uterinas, prega nuchal e medida do colo uterino via transabdominal.
- C) Doppler de ducto venoso, osso nasal e medida do colo uterino via transabdominal.
- D) Doppler de valva tricúspide, prega nuchal e medida do colo uterino via transvaginal.
- E) Doppler de artérias uterinas, osso nasal e medida do colo uterino via transvaginal.

69 - C.N.B., 38 anos, primigesta, gestação gemelar dicoriônica e diamniótica, idade gestacional de 23 semanas, veio à Medicina Fetal para ultrassom morfológico de segundo trimestre. Nega comorbidades. Paciente foi submetida à medida do colo uterino, e a presença do ecoglandular endocervical não foi identificada. Comprimento do colo uterino: 10 mm. Sinal do sludge presente. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada para o caso.

- A) Pessário cervical.

- B) Progesterona isolada via vaginal.
- C) Progesterona isolada via oral.
- D) Cerclagem uterina e antibiótico EV.
- E) Cerclagem uterina e antibiótico VO.

70 - C.N.B., 38 anos, primigesta, gestação gemelar dicoriônica e diamniótica, idade gestacional de 23 semanas, veio à Medicina Fetal para ultrassom morfológico de segundo trimestre. Nega comorbidades. A respeito da zigoticidade, corionicidade e amnionicidade dessa gestação gemelar, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se certamente de uma gestação monozigótica.
- B) Trata-se certamente de uma gestação dizigótica.
- C) Trata-se de uma gestação com 2 âmnios e 2 placentas.
- D) Trata-se de uma gestação com 1 córion e 2 âmnios.
- E) Trata-se de uma gestação com 2 placentas e 1 âmnio.

71 - R.N.B., 32 anos, GIII PI 1C há 4 anos AI, idade gestacional de 34 semanas, IMC 24 kg/m², deu entrada no pronto-socorro obstétrico, encaminhada pelo pré-natal de alto risco por PA: 160x100 mmHg e ultrassom obstétrico com doppler, demonstrando feto com peso fetal no p2, doppler de artéria umbilical com diástole zero e ducto venoso normal. Paciente nega comorbidades. Exames laboratoriais: relação proteína na urina/creatinina na urina: 0,3; plaquetas 150.000, creatinina 0,9, TGO 30, TGP 20, bilirrubinas normais. De acordo com o caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto.

- A) Hipertensão arterial crônica.
- B) Doença hipertensiva específica da gestação.
- C) Pré-eclâmpsia superajuntada.
- D) HELLP parcial.
- E) HELLP completa.

72 - R.N.B., 32 anos, GIII PI 1C há 4 anos AI, idade gestacional de 34 semanas, IMC 24 kg/m², deu entrada no pronto-socorro obstétrico, encaminhada pelo pré-natal de alto risco por PA: 160x100 mmHg e ultrassom obstétrico com doppler, demonstrando feto com peso fetal no p2, doppler de artéria umbilical com diástole zero e ducto venoso normal. Paciente nega comorbidades. Exames laboratoriais: relação proteína na urina/creatinina na urina: 0,3; plaquetas 150.000, creatinina 0,9, TGO 30, TGP 20, bilirrubinas normais. De acordo com o caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) Indução do trabalho de parto com misoprostol.
- B) Dilatação mecânica do colo uterino com sonda de Foley.
- C) Parto cesariano.
- D) Internação com acompanhamento diário de ducto venoso.
- E) Sulfato de magnésio dose de ataque e manutenção e indução do trabalho de parto com ocitocina.

73 - Mulher de 49 anos vem à consulta ginecológica queixando-se de calorões noturnos, irritabilidade, falha de memória e disfunção sexual. Alega amenorreia há cerca de 4 meses. Refere hipertensão arterial crônica controlada, diabetes com controles normais. Em uso de losartana e metformina. IMC 32 kg/m². Nega cirurgias prévias. Dos exames laboratoriais recentes, verificado FSH de 130 UI/L. De acordo com o caso e com os estudos mais recentes, assinale a alternativa que apresenta o tratamento mais eficaz para o controle dos sintomas.

- A) Estrogênio via vaginal.
- B) Estrogênio mais progesterona conjugada via oral.
- C) Estrogênio isolado via transdérmica.
- D) Estrogênio transdérmico e progesterona via oral.
- E) Fitoestrógeno isolado via oral.

74 - Puérpera no 47º dia pós-parto vaginal vem ao consultório ginecológico solicitando um método contraceptivo. Em amamentação materna exclusiva, sente-se insegura, com medo da possibilidade de engravidar. Refere ter tido infecção puerperal, ainda em tratamento com antibioticoterapia. Nega outras comorbidades. De acordo com o caso, assinale a alternativa que apresenta o método contraceptivo correto.

- A) Dispositivo intrauterino de cobre.
- B) Anticoncepcional hormonal via implante subcutâneo com progestágeno.
- C) Anticoncepcional hormonal combinado oral.
- D) Anticoncepcional hormonal combinado transdérmico.
- E) Anticoncepcional hormonal combinado injetável.

75 - Menina de 16 anos é trazida pela mãe, aflita, em consulta ginecológica, por filha ainda não ter apresentado a menarca e não possuir caracteres sexuais secundários. Assinale a alternativa que representa o primeiro exame indicado para a investigação do caso.

- A) Histeroscopia.
- B) Dosagens de estradiol.
- C) Teste da progesterona.
- D) Dosagens de FSH e LH.
- E) Cariótipo.

76 - Mulher de 34 anos, com infertilidade primária há 3 anos. O espermograma do parceiro é normal. A histerossalpingografia demonstrou teste de Cotte positivo bilateralmente. No 24º dia do ciclo, a dosagem sérica de progesterona foi de 1 ng/mL, e a histologia da biópsia de endométrio foi compatível com a fase proliferativa. De acordo com o caso, assinale a alternativa que apresenta a opção de tratamento correto.

- A) Prescrever citrato de clomifeno.
- B) Indicar videolaparoscopia.
- C) Prescrever progesterona na segunda fase do ciclo.
- D) Prescrever estradiol na primeira fase do ciclo.

E) Indicar a hidrintubação.

77 - O esquema das duas células ocorre no folículo antral e representa a esteroidogênese ovariana. De acordo com esse sistema, assinale a alternativa correta.

- A) O FSH une-se ao seu receptor na célula da teca.
- B) Na célula da teca, a androstenediona e a testosterona são transformadas em colesterol.
- C) O LH une-se ao receptor da célula da granulosa.
- D) O FSH ativa a enzima aromatase.
- E) A aromatase quebra o estradiol em testosterona.

78 - Assinale a alternativa que apresenta os critérios clínicos ambulatoriais (Amsel) para o diagnóstico de vaginose bacteriana.

- A) Secreção branca, pH vaginal maior que 5, teste das aminas negativo.
- B) Secreção acinzentada, pH vaginal de 3,5, clue cells presentes no exame microscópico.
- C) Secreção acinzentada, pH vaginal menor que 3,5, presença de hifas no exame microscópico.
- D) Secreção acinzentada, pH vaginal maior que 5, teste das aminas positivo, presença de células gigantes multinucleadas à microscopia.
- E) Secreção acinzentada, pH vaginal maior que 5, teste das aminas positivo, clue cells no exame microscópico.

79 - Mulher de 30 anos vem ao pronto-socorro com queixa de febre e dor em hipogástrio. Realizado ultrassom transvaginal, que evidenciou: massa complexa, sugestiva de abscesso tubo-ovariano de 4,5 cm, sem líquido livre em cavidade pélvica. Paciente refere vida sexual ativa, em uso de dispositivo intrauterino de cobre. Assinale a alternativa que apresenta a conduta inicial mais adequada para o caso.

- A) Culdocentese.
- B) Laparotomia.
- C) Laparoscopia.
- D) Punção guiada por ultrassonografia.
- E) Antibioticoterapia.

80 - R.G.B., 26 anos, vem ao consultório ginecológico com queixa de irritabilidade, perda de controle com o esposo, labilidade emocional e tristeza. Não quer sair de casa para trabalhar, todos os meses, previamente à menstruação. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a principal hipótese diagnóstica.

- A) Transtorno disfórico pré-menstrual.
- B) Síndrome pré-menstrual.
- C) Transtorno bipolar.
- D) Depressão.
- E) Molimen menstrual.

81 - Um trabalhador informal sofre uma picada por animal peçonhento. É levado rapidamente a um serviço de urgência e emergência, onde são tomadas as providências para controle clínico. Esse evento é de notificação compulsória imediata no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Assinale a alternativa correta sobre essa afirmação.

- A) A afirmação é correta somente se o trabalhador tiver sido picado durante sua jornada de trabalho.
- B) A afirmação é correta.
- C) A afirmação é incorreta, pois acidentes envolvendo trabalhadores informais não são de notificação compulsória imediata.
- D) A afirmação é incorreta, pois acidentes com animais peçonhentos não requerem notificação imediata.
- E) A afirmação é correta somente se o animal peçonhento for uma cobra venenosa.

82 - Durante uma consulta de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a equipe de saúde identifica sinais de possível violência doméstica em uma gestante que reside com o marido e com a sogra. Assinale a alternativa correta a respeito dessa situação.

- A) A equipe de saúde deve investigar a possível violência doméstica, garantindo, simultaneamente, a continuidade do pré-natal.
- B) O cuidado com a mulher deve restringir-se ao seu aparelho reprodutivo, cabendo à equipe apenas encaminhá-la à polícia para registrar queixa.
- C) A equipe de saúde deve solicitar o apoio da sogra para apurar a ocorrência de violência doméstica.
- D) O marido deve ser chamado pela equipe de saúde para confessar atos de violência, sem que a gestante tenha conhecimento.
- E) Para protegê-la, a equipe deve notificar a polícia sobre a suspeita de violência doméstica sem informar a usuária.

83 - Uma criança de 7 anos, usuária de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), passa a demonstrar sofrimento para ir à escola, segundo relato de sua mãe. Entusiasmada no início de sua vida escolar, após 2 meses, começa a usar fatos corriqueiros como desculpa para faltar às aulas. A equipe de saúde se reúne para se debruçar sobre o caso. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta nesse caso.

- A) A equipe aconselha a família a estipular um prêmio para a criança no final de cada mês em que ela não tiver nenhuma falta.
- B) Partindo da premissa de que o único compromisso fixo das crianças é ir à escola, ela deve ser obrigada pelos pais a não faltar.
- C) A família e a equipe devem acolher a criança, buscando o diálogo para verificar os motivos da mudança de comportamento da criança.
- D) As crianças nessa idade costumam, de fato, apresentar resistência a manter uma rotina de estudos, e, com persistência, essa fase tende a passar.
- E) A criança deve ser encaminhada para um psiquiatra, pois essa mudança de comportamento pode representar algum quadro mais grave.

84 - Em uma cidade em que a doença X tem maior coeficiente de letalidade que a doença Y:

- A) A doença X tende a ser mais grave do que a doença Y.
- B) A doença X tende a ser mais contagiosa do que a doença Y.
- C) A doença X tende a ter maior coeficiente de incidência do que a doença Y.
- D) A doença X tende a ter maior coeficiente de prevalência do que a doença Y.
- E) As doenças X e Y teriam coeficientes de letalidade semelhantes se a assistência hospitalar fosse melhor.

85 - Uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada próximo a uma empresa de logística que distribui produtos de cuidados pessoais e beleza tem recebido um aumento significativo de atendimentos a trabalhadoras da empresa. Elas relatam dores nos braços, ombros, região cervical e lombar, associadas à longa jornada de trabalho, de cerca de 10 horas diárias, incluindo horas extras, com apenas uma pausa para almoço. Os diagnósticos incluem epicondilite, tendinite em punhos e ombros, hérnia de disco, entre outras doenças. Considerando essa situação, assinale a alternativa correta.

- A) A equipe de saúde deve encaminhar todas as trabalhadoras ao CEREST mais próximo, mesmo que localizado em outro município, pois se trata de um problema relacionado ao trabalho.
- B) Como a empresa possui convênio médico, as trabalhadoras devem ser direcionadas exclusivamente a esse serviço, já que o SUS deve priorizar quem não tem acesso a planos de saúde.
- C) Os casos devem ser notificados ao SINAN e, posteriormente, a empresa deve ser responsabilizada pelo tratamento, já que as doenças foram causadas pelas condições de trabalho.
- D) A equipe deve notificar imediatamente a auditoria fiscal do Ministério do Trabalho, única responsável por intervir em ambientes laborais, e encaminhar as funcionárias ao convênio da empresa.
- E) Os casos devem ser notificados ao SINAN, a vigilância em saúde deve ser acionada para investigação, e as trabalhadoras devem receber acompanhamento médico, seja pelo SUS ou pelo convênio da empresa.

86 - Assinale a alternativa correta relacionada à conduta que um médico deve tomar diante de um paciente de 47 anos de idade, internado em estado grave e com probabilidade de morte.

- A) O médico deve informar aos familiares sobre a gravidade do caso, deixando-lhes a responsabilidade de comunicá-la ao paciente.
- B) O médico deve dar o mínimo de informações ao paciente para não desencadear reações negativas que poderão agravar o quadro clínico.
- C) O médico deve informar os familiares sobre a real situação do paciente e só poderá comunicar ao paciente se a família autorizar.
- D) O médico deve informar o paciente sobre a gravidade do problema e sobre a situação real, como ela é.
- E) Caso o médico avalie que o paciente não tem condições psicológicas de ouvir a situação real, deve amenizar a gravidade do quadro.

87 - No Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) de um município, verifica-se que o número de óbitos decorrentes de acidentes de trabalho é muito subnotificado. Assinale a alternativa correta a esse respeito.

- A) Os médicos que preenchem e assinam as declarações de óbito não estão assinalando o campo correspondente a essa informação.
- B) Para que haja uma vigilância epidemiológica nesse caso, o primeiro passo a ser tomado é um treinamento sobre o SINAN, que poderá alimentar o SIM.
- C) Óbitos decorrentes de acidentes de trabalho são investigados pela polícia e são registrados em outro sistema, não no SIM.
- D) Apenas os casos de óbitos decorrentes de acidentes de trabalho que passam pelo Instituto Médico Legal (IML) são notificados no SIM.
- E) É possível que essa subnotificação ocorra por falta de médicos legistas, que são os únicos que alimentam o SIM.

88 - Assinale a alternativa correta referente à vigilância sobre a tuberculose.

- A) A alta incidência de tuberculose nas populações privadas de liberdade se deve principalmente à proximidade física, e poucas medidas são consideradas efetivas para o controle da doença.
- B) Nas populações indígenas, a presença de tosse merece observação, mas, a partir de 4 semanas, enseja a realização de baciloscopia ou teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) e radiografia de tórax.
- C) Uma das populações merecedoras de atenção especial na vigilância sobre a tuberculose é a de pessoas vivendo com HIV, as quais devem ser sempre questionadas sobre existência de tosse, independentemente da duração, e/ou febre e/ou perda de peso e/ou sudorese noturna.
- D) Embora estejam em vulnerabilidade social, populações em situação de rua não são prioritárias na vigilância sobre a tuberculose, pois vivem a céu aberto, tendo poucas possibilidades de se infectar.
- E) A vacina BCG previne as formas graves da doença, como miliar e meníngea na criança, além de proteger indivíduos já infectados pelo *M. tuberculosis* e de evitar o adoecimento por reativação endógena ou reinfeção exógena.

89 - Os dados em uma cidade mostram que, em março de 2024, 10 a cada 1.000 homens entre 30 e 45 anos estavam com uma doença X, e 30 a cada 1.000 mulheres na mesma faixa etária estavam com a mesma doença X. Conclui-se que o risco de que as mulheres tenham a doença X é 3 vezes maior que o risco dos homens. Assinale a alternativa correta sobre o caso apresentado.

- A) A afirmação de que o risco de as mulheres terem a doença X é 3 vezes maior do que os homens só pode ser feita se essa proporção se mantiver ao longo de, pelo menos, um ano.
- B) A afirmação de que o risco de as mulheres terem a doença X é 3 vezes maior do que os homens é correta.
- C) Para que se possa comparar os riscos de cada um dos grupos populacionais ter a doença X, é preciso estratificar por diferentes faixas etárias e analisar dados em um período de, pelo menos, 10 anos.

D) A afirmação de que o risco de as mulheres terem a doença X é 3 vezes maior do que os homens é correta se a população da cidade for estável no último ano.

E) Não é possível estimar o risco de qualquer um dos grupos populacionais ter a doença X, pois, com os dados do enunciado, não se consegue calcular o coeficiente de incidência.

90 - Um usuário do SUS é internado em um hospital com previsão de permanência de 7 dias e, embora ele queira ter como acompanhante uma grande amiga, recebe a informação de que isso não é possível. Assinale a alternativa correta a esse respeito.

A) A permissão de acompanhante é obrigatória somente nos casos de internação longa.

B) O hospital está correto, pois a presença de acompanhante atrapalha a rotina.

C) Se o hospital tiver sistema de visita aberta, pode vetar a presença de acompanhante.

D) Essa informação contraria a Política Nacional de Humanização do SUS.

E) O hospital está correto, pois o acompanhante tem que ser um familiar do usuário.

91 - Em uma cidade castigada por altas temperaturas durante boa parte do ano, um movimento de motoristas, ciclistas, trabalhadoras domésticas, entre outros segmentos populacionais, procura o Secretário de Saúde, pedindo apoio para que sejam instalados, em diferentes pontos, quiosques com telhas e boa ventilação, providos de água potável. Assinale a alternativa correta a esse respeito.

A) Embora seja importante para a população, essa reivindicação extrapola a área de Saúde e deve ser encaminhada para o setor de obras da Prefeitura.

B) A ideia deve ser apoiada pelo Secretário de Saúde, pois se trata de uma medida de promoção da saúde e prevenção de problemas de saúde por exposição ao sol e desidratação.

C) Mesmo que o Secretário de Saúde goste da ideia, há outras prioridades, como construção de hospitais e unidades de urgência e emergência.

D) A ideia é boa, mas deve ser implementada somente após ampla campanha para que os quiosques não sejam depredados.

E) Trata-se de uma medida cosmética, pois não se resolveria a questão central, que é a crise climática que castiga todas as cidades.

92 - Durante a pandemia de covid-19, em uma comunidade de baixa renda, houve muitas mortes, principalmente entre as trabalhadoras domésticas. Disseminou-se a ideia de que os casos eram graves, porque os vírus eram invencíveis, motivo pelo qual se criou uma resistência contra a vacina. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como essa resistência pode ser combatida.

A) Confecção de cartilhas com referências bibliográficas de fonte confiável para que sejam distribuídas para todas as pessoas.

B) Programação de palestras e aulas de médicos renomados nas escolas para que os estudantes convençam suas famílias da importância da vacina no controle da doença.

C) Capacitação das equipes de saúde da família para que trabalhem junto à população com atividades diversificadas que contribuam para a construção do cuidado à saúde.

D) Disponibilização de textos científicos elucidativos sobre as histórias das vacinas e o bem que fizeram à humanidade.

E) Divulgação de filmes com pronunciamentos de autoridades governamentais apelando para que a população compareça às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para se vacinarem.

93 - Assinale a alternativa que apresente uma doença contra a qual não há vacina ainda.

- A) Poliomielite.
- B) Hepatite B.
- C) Dengue.
- D) Febre amarela.
- E) Esquistossomose.

94 - Assinale a alternativa correta sobre a longitudinalidade, um dos atributos da Atenção Básica.

- A) A longitudinalidade se refere ao vínculo proporcionado por uma doença.
- B) A capacitação técnica do médico é a principal característica da longitudinalidade.
- C) A longitudinalidade não inclui o vínculo terapêutico entre suas dimensões.
- D) A troca constante de médicos tende a atrapalhar a concretização da longitudinalidade.
- E) Um bom prontuário é o recurso mais importante para que a longitudinalidade ocorra.

95 - Assinale a alternativa correta sobre as Regiões de Saúde.

- A) São instituídas pelo Estado, em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
- B) Para serem instituídas, devem conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, vigilância em saúde e saúde do trabalhador.
- C) São instituídas conforme cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, de acordo com decisão do Congresso Nacional.
- D) Todas as Regiões de Saúde devem ter populações usuárias de ações e serviços com dimensões e características similares.
- E) As Regiões de Saúde devem obedecer aos limites dos estados.

96 - Pessoas com fatores de risco para diabetes mellitus devem ser encaminhadas para a consulta de rastreamento e a realização do exame de glicemia. Assinale a alternativa que apresenta um desses fatores.

- A) Mulher com história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg.
- B) Mulher submetida à histerectomia.
- C) Pessoa com antecedente de câncer de pulmão.
- D) Homem com tuberculose miliar.
- E) Pessoa com história de desnutrição.

97 - O motorista de um caminhão colide com um outro veículo de grande porte e é levado a um hospital. É submetido a uma cirurgia por rompimento de órgãos internos, contrai pneumonia depois de 3 dias e morre depois de 7 dias, por septicemia. Assinale a alternativa que apresenta a causa básica do óbito.

- A) Parada cardiorrespiratória.
- B) Impacto por colisão de veículo automotivo.
- C) Lesões de órgãos internos.
- D) Septicemia.
- E) Pneumonia.

98 - Assinale a alternativa que apresenta o evento diretamente relacionado à criação do SUS.

- A) 17º Encontro Científico dos Estudantes de Medicina em 1986.
- B) 38ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência de 1986.
- C) 8ª Conferência Nacional de Saúde.
- D) Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde de Alma-Ata.
- E) Reunião de Secretários de Saúde Estaduais em 1986.

99 - Assinale a alternativa correta sobre documentos médicos, segundo o Código de Ética Médica.

- A) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência em quaisquer circunstâncias.
- B) É vedado ao médico atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, exceto quando um outro médico lhe passe o caso por escrito.
- C) É permitido ao médico atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos em formulário institucional em quaisquer circunstâncias, desde que pertença à instituição.
- D) É vedado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.
- E) É permitido ao médico assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos desde que tenha confiança no portador.

100 - Uma equipe de saúde suspeita de efeito adverso pós-vacinação (EAPV) em um usuário do SUS que procura o serviço de urgência e emergência com quadro de certa gravidade. Assinale a alternativa correta sobre EAPV.

- A) O diagnóstico de EAPV pode ser feito apenas se a vacina for a única causa possível do evento motivador da procura do serviço de saúde que pode ser demonstrada.
- B) Um dos critérios para o estabelecimento do nexo de causalidade é a plausibilidade e coerência biológica.
- C) Nos casos de vacinas de vírus inativado, é mais provável a possibilidade de se obter a prova definitiva do nexo de causalidade.
- D) Qualquer médico clínico está habilitado para investigar o nexo de causalidade entre a vacina e o evento em questão.
- E) O processo de investigação de nexo de causalidade entre a vacina e um evento é relativamente simples.

GABARITO

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
D	E	C	A	D	B	C	B	B	B
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
A	D	A	A	D	C	D	C	A	C
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
E	D	C	C	D	A	E	D	C	E
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
B	A	D	B	E	D	C	B	A	D
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
C	D	E	C	B	D	C	C	E	A
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
C	A	B	A	D	B	A	A	D	A
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
A	C	A	E	C	C	A	D	A	B
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
B	E	D	C	E	C	E	E	C	C
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
B	D	B	B	A	D	D	E	E	D
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
C	B	E	E	E	A	C	B	D	B

QUESTÃO ANULADA = X